Psicopatología de la audición y el lenguaje

Unidad 3. Trastornos del lenguaje oral y escrito: identificación, abordaje y parámetros diferenciadores

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 1
INTRODUCCIÓN 2
TAXONOMÍA DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL Y DEL APRENDIZAJE 3
Sección 2.1 Introducción 3
Sección 2.2 Trastornos del lenguaje: Continuación y profundización del tema 2. 3
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 11
Sección 3.1 Criterios diagnósticos: DSM-V 11
Sección 3.2 Dislexia 12
Sección 3.3 Disortografía 13
Sección 3.4 Discalculia 14
OTROS TRASTORNOS 16
Sección 4.1 Criterios diagnósticos: DSM-V 16
Sección 4.2 Hipergrafía 17
RESUMEN DEL TEMA 18
GLOSARIO 21
BIBLIOGRAFÍA 24

INTRODUCCIÓN

La adquisición del lenguaje oral y escrito es fruto de un proceso interactivo, donde niño y adulto ajustan mutuamente su comportamiento para llegar a establecer definiciones compartidas de las situaciones y una complicidad creciente. El lenguaje contribuye a entender el punto de vista de los demás y a desarrollar la empatía. Los niños con habilidades lingüísticas bien desarrolladas pueden disfrutar de la interacción con otros niños. Las habilidades lingüísticas les permiten disfrutar de los juegos cooperativos, que requieren instrucciones y reglas (Sala, 2020).

A nivel emocional, el lenguaje permite más independencia, autocontrol y seguridad personal. Cuando un niño no puede expresar lo que siente o no entiende lo que se le dice, puede reaccionar con desinterés o agresividad y tener un bajo concepto de sí mismo (Billard, 2014). Cualquier alteración del lenguaje puede modificar la dinámica de la interacción e influir negativamente en sus relaciones con los demás.

Tomando como referencia lo anterior, esta unidad tres tiene por objetivos: (1) aproximarse de forma teórica a los conceptos relacionados con los trastornos del lenguaje oral y del aprendizaje; (2) conocer la clasificación de los diferentes trastornos del lenguaje oral y del aprendizaje según ciertos criterios; y (3) poder identificarlos en torno a sus características específicas.

TAXONOMÍA DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL Y DEL APRENDIZAJE

Sección 2.1 Introducción

La adquisición y desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino también de socialización, humanización, del pensamiento y autocontrol de la propia conducta.

El lenguaje oral es determinante en el desarrollo mental y el proceso de socialización del ser humano. La adquisición del sistema lingüístico, interrelacionado con el medio, favorece el desarrollo del proceso social y de adaptación al medio, ya que pone en contacto procesos cognitivos de atención, memoria, pensamiento, imaginación, generalización, abstracción…

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que un trastorno del lenguaje oral se da cuando se detectan problemas en la adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado, en cualquiera de sus cuatro componentes (fonético, morfosintáctico, léxico o pragmático).

Dentro de estos problemas se observa la ausencia del lenguaje, su aparición tardía, o características en el lenguaje del niño propias de un estadio evolutivo anterior. Así, dentro de los trastornos del lenguaje oral, pueden diferenciarse, según su grado de gravedad, y siguiendo a Gallardo y Gallego (2003), el inicio tardío del Lenguaje (IT), Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, el Trastorno de Aprendizaje No Verbal y las Afasias.

En el año 2026 se ha publicado el estudio Delphi, el cual recoge un proceso de consenso entre expertos. Participaron 51 especialistas de distintos países hispanohablantes y, mediante dos rondas de consulta, llegaron a 25 acuerdos principales (Andreu, et al. 2026). Nos basamos en la reciente publicación para exponer la clasificación de los trastornos del lenguaje.

Sección 2.2 Trastornos del lenguaje: Continuación y profundización del tema 2.

2.2.1 Inicio tardío del lenguaje

Existen niños que padecen Trastorno del Lenguaje Tardío (IT) sin presentar otras alteraciones evidentes. Sus rasgos principales son un vocabulario limitado, con menos de 50 palabras inteligibles, o la falta de emisiones de dos palabras a los 24 meses de edad. Este fenómeno se manifiesta de manera diversa, ya que algunos niños solo experimentan retraso en la expresión, mientras que otros pueden tener dificultades tanto expresivas como receptivas (Martínez, 2017).

Hasta la fecha, no existen criterios de diagnóstico para el IT en las clasificaciones oficiales, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-5 (DSM-5) o la Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento-11 (CIE-11). Sin embargo, se aceptan ampliamente los criterios propuestos por la Asociación Americana del Habla y la Audición (ASHA) y por Rescorla y Achenbach para la detección del IT (Crespo-Allende y Alfaro-Faccio, 2010).

La prevalencia del IT en niños de 2 años varía del 9.6% (12.8% en niños y 6.5% en niñas) al 13.71%. Sin embargo, no todos los niños con inicio tardío en el habla experimentan problemas

de lenguaje cuando llegan a la edad escolar, lo que dificulta el diagnóstico de un posible trastorno del lenguaje antes de los 3 años (Moreno-Flagge, 2013).

Se podría considerar que la incidencia de un trastorno persistente del lenguaje en niños con IT es del 44.1% a los 3 años, disminuyendo al 40.2% a los 4 años. Estos resultados sugieren que aproximadamente el 56% de los niños experimenta una mejora espontánea en sus dificultades de lenguaje a los 3 años, pero solo un 4% muestra remisión a partir de los 4 años.

Si las dificultades persisten más allá de los 2-3 años, es poco probable que remitan en el siguiente año de vida, lo que resalta la importancia de un seguimiento continuo (Barragán y Lozano, 2011).

Algunos niños que desarrollan un lenguaje aparentemente normal pueden enfrentar desafíos en habilidades más complejas, como narrar una historia a los 5 años, el discurso y la morfosintaxis a los 7 años, lectura y ortografía a los 9 años, vocabulario, gramática, memoria verbal y comprensión de la lectura a los 13 años, y vocabulario, gramática y memoria verbal a los 17 años (Peñafiel, 2012).

El consenso Delphi (Andreu et al., 2026) no propone utilizar “inicio tardío del lenguaje” como equivalente de trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL. El ITL describe fundamentalmente una característica del desarrollo temprano o un momento de aparición tardío del lenguaje, mientras que el TDL es una categoría diagnóstica que implica persistencia y afectación funcional. El consenso sitúa además la identificación de dificultades graves y persistentes a partir de los 4 años, lo que refuerza la necesidad de no convertir automáticamente una manifestación temprana como “hablar tarde” en un diagnóstico de TDL. Así, un niño que presenta un inicio tardío puede posteriormente mostrar una evolución compatible con un desarrollo dentro de la variabilidad esperable o, por el contrario, presentar dificultades persistentes que justifiquen un diagnóstico de TDL; la etiqueta inicial de “inicio tardío” no determina por sí misma ese desenlace.

Finalmente, se recomienda que los niños de entre 24 y 30 meses con dificultades tanto en la comprensión como en la expresión del lenguaje se beneficien de una intervención temprana, especialmente cuando los padres están directamente involucrados en el tratamiento.

2.2.2 Trastorno del Desarrollo del Lenguaje

Trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta cuando se experimentan dificultades para hablar o comprender el lenguaje. Esto se caracteriza por la presencia de un vocabulario limitado, construcciones morfosintácticas deficientes y alteraciones significativas en el discurso, lo que resulta en limitaciones en la interacción social, la comunicación y el rendimiento académico (Ahufinger et al., 2021).

Por lo general, este trastorno se detecta típicamente a partir de los 4 años y tiene una prevalencia estimada del 7,58%. Sin embargo, debido a diferencias en los métodos de diagnóstico, instrumentos de evaluación y criterios de cohorte utilizados, no se puede confirmar con certeza su prevalencia exacta (Hincapié et al., 2008).

Hasta el año 2020, este trastorno se conocía comúnmente como "trastorno específico del lenguaje" (TEL). Sin embargo, en ese año se adoptó la denominación "trastorno del desarrollo del lenguaje" (TDL) debido a que, aunque el lenguaje es el déficit principal en niños con TDL, a menudo se acompaña de otros problemas cognitivos o alteraciones del desarrollo (Bishop et al., 2017).

Los niños con TDL a menudo comienzan a hablar más tarde de lo esperado. Algunos pueden no pronunciar sus primeras palabras hasta los 2 años y no comenzar a formar frases de dos palabras hasta los 3 años (Magdalena, 2020). A medida que adquieren habilidades lingüísticas, pueden tener dificultades para expresarse verbalmente y, en ocasiones, recurren a gestos y sonidos para comunicarse. Además, pueden enfrentar dificultades para comprender el lenguaje y a menudo dependen del contexto visual para comprender los mensajes verbales.

En las etapas tempranas, cuando la comunicación está seriamente afectada, el TDL puede ser confundido con el Trastorno del Espectro del Autismo. Sin embargo, con el tiempo, algunos niños con un Retraso Simple del Lenguaje pueden superar las dificultades iniciales (Bishop y Leonard, 2001).

El reciente consenso hispanohablante de 2026 define el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) como un trastorno que afecta de manera significativa y persistente al desarrollo del lenguaje oral y que no se explica por una causa biomédica identificable (una condición o enfermedad identificable que puede explicar las dificultades de lenguaje). Los expertos consensúan utilizar “TDL” para aquellos casos sin una condición biomédica que explique las dificultades. El trastorno puede afectar a distintas dimensiones del lenguaje —fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y/o discurso— y no es necesario que todas estén alteradas. (Andreu et al., 2026)

En cuanto al diagnóstico, el consenso insiste en que no debe establecerse a partir de una única prueba ni de un único punto de corte. Se recomienda una evaluación exhaustiva, multidimensional y clínico-funcional, que integre pruebas estandarizadas y cualitativas, observación clínica, muestras de lenguaje espontáneo y la información proporcionada por la familia y el contexto educativo. Deben considerarse diferentes dimensiones de la comunicación y aspectos como lenguaje receptivo y expresivo, pragmática, habla, audición y funcionamiento cognitivo. Los expertos sitúan el diagnóstico de TDL preferentemente a partir de los 4 años, cuando las dificultades pueden identificarse como persistentes, graves y con repercusión funcional, especialmente en la participación social, el aprendizaje y el funcionamiento escolar. La respuesta limitada a la intervención constituye también un elemento relevante para valorar la persistencia de las dificultades (Andreu et al., 2026)

Por último, el consenso establece que el TDL puede coexistir con otros trastornos, aunque determinadas condiciones biomédicas excluyen la utilización de la etiqueta TDL porque proporcionan una explicación del trastorno del lenguaje. Esto supone un cambio importante respecto a concepciones anteriores: no se pretende encontrar una única “prueba” que determine el diagnóstico, sino integrar la evidencia lingüística, clínica y funcional. El logopeda/fonoaudiólogo ocupa un papel central en la evaluación y el diagnóstico —con acuerdo del 100 % de los expertos en esta cuestión—, pero se defiende un abordaje interdisciplinar que incluya, cuando sea necesario, pediatría, neuropediatría, psicología, audiología, educación y familia (Andreu et al., 2026)

Por lo tanto, se desaconseja realizar un diagnóstico demasiado temprano, ya que podría carecer de precisión. Es crucial observar al niño a lo largo del tiempo para establecer un diagnóstico fiable, generalmente a los 4 años.

2.2.3 Trastorno del Lenguaje

El Trastorno del Lenguaje (TL) se define como una alteración persistente del desarrollo del lenguaje oral que afecta de manera significativa a la comunicación y que puede tener consecuencias a lo largo del desarrollo y durante diferentes etapas de la vida. El consenso de 2026 propone utilizar el término *trastorno del lenguaje* para referirse a las dificultades persistentes que afectan al desarrollo comunicativo. Las dificultades pueden manifestarse en diferentes componentes o dominios del lenguaje, por lo que no existe un único perfil lingüístico que defina a todas las personas con TL o TDL. Pueden verse comprometidos aspectos como la comprensión y la expresión, el vocabulario y la semántica, la morfología, la sintaxis, la fonología, la pragmática o el discurso. Precisamente por esta heterogeneidad, el consenso rechaza la creación de subtipos formales del trastorno. En lugar de clasificar a una persona dentro de categorías rígidas como “expresivo”, “receptivo” o “mixto”, recomienda realizar una descripción detallada de qué dominios lingüísticos están afectados y cómo se manifiestan las dificultades en cada persona (Andreu et al., 2026).

Una característica fundamental es que el trastorno debe entenderse desde una perspectiva clínica y funcional, y no únicamente a partir de la puntuación obtenida en una prueba de lenguaje. El diagnóstico requiere una evaluación integral y multidimensional que permita identificar dificultades que sean suficientemente importantes, persistentes y relevantes para el funcionamiento comunicativo. El consenso señala que pueden identificarse dificultades graves y persistentes a partir de los 4 años, pero la determinación diagnóstica debe considerar el conjunto de la información disponible y no depender de un único instrumento o criterio. Asimismo, el trastorno puede coexistir con otras dificultades o trastornos, por lo que la presencia de comorbilidades no implica automáticamente que las dificultades lingüísticas dejen de ser clínicamente relevantes (Andreu et al., 2026).

Finalmente, el rasgo que permite diferenciar el TDL de otros trastornos del lenguaje es fundamentalmente la ausencia de una condición biomédica identificable que explique las dificultades lingüísticas. Determinadas condiciones biomédicas excluyen el diagnóstico de TDL, mientras que otras dificultades pueden coexistir con él. De este modo, el consenso propone una concepción del trastorno que pone el énfasis en la persistencia, la gravedad, el impacto funcional, la heterogeneidad de los perfiles lingüísticos y la necesidad de una evaluación multidimensional, evitando reducir el diagnóstico a una etiqueta basada en un único componente del lenguaje. El objetivo de estos acuerdos es precisamente avanzar hacia una terminología y unos criterios más homogéneos entre los profesionales de los países hispanohablantes.

Tabla 1.

Comparación entre TDL y TL, de acuerdo con el consenso Delphi (Andreu et al.,2026) creación propia.

	Trastorno del Lenguaje	**Trastorno del Desarrollo del Lenguaje**
Qué es	Alteración persistente y significativa del lenguaje que afecta el funcionamiento comunicativo.	Un tipo de Trastorno del lenguaje en el que las dificultades lingüísticas no se

		explican por una condición biométicа identificable.
Relación entre ambos	En el término más amplio.	Esta dentro del TL.
Causa biomédica	Puede existir o no una condición biomédica asociada que explique las dificultades.	No debe existir una condición biométicа identificable que explique las dificultades lingüísticas.
Ejemplo	Un niño con síndrome de Down que presenta dificultades importantes de lenguaje → TL asociado a una condición biomédica.	Un niño con dificultades persistentes de lenguaje, sin discapacidad intelectual, TEA u otra condición biomédica que las explique → TDL.
Áreas afectadas	Puede afectar comprensión, expresión, vocabulario, semántica, morfología, sintaxis, fonología, pragmática y/o discurso.	Exactamente igual: no hay un perfil único.
Diagnóstico	Requiere evaluación integral, multidimensional y funcional; no depende de una única prueba.	Igual: debe existir evidencia de dificultades persistentes, significativas y funcionalmente relevantes.
Edad	Las dificultades pueden observarse durante el desarrollo, pero la valoración debe considerar la trayectoria evolutiva.	El consenso considera que las dificultades graves y persistentes pueden identificarse a partir de los 4 años.
Puede existir con otras dificultades	Sí.	Sí. La presencia de determinadas dificultades asociadas no excluye automáticamente el TDL; depende de si existe una condición biomédica que explique el trastorno lingüístico.

2.3. Trastorno de Aprendizaje No Verbal

Siguiendo a Cruz-Hernández y Salvador-Cruz (2020), particularmente, el déficit en las habilidades no verbales se puede etiquetar como Trastorno de Aprendizaje No Verbal (TANV), que de manera general, se define como una categoría clínica neuropsicológica caracterizada por

una serie de déficits en el razonamiento espacial, en la actividad visoconstructiva, en el control motor fino y táctil, acompañado frecuentemente con impedimentos en el funcionamiento socioemocional, evidenciando como principal característica, la discrepancia entre la inteligencia verbal y viso-perceptual en las Escalas de Inteligencia de Wechsler (WISC, WISC-R).

En relación con ello, tal y como exponen, Harnadek y Rourke (1994), en Del Olmo (2022), deben tenerse en cuenta una serie de características que llevarían a describir, perfectamente, esta alteración teniendo en cuenta las siguientes características:

- Déficits bilaterales en la percepción táctil, algo más marcado en el hemicuerpo izquierdo.
- Déficits bilaterales en coordinación psicomotora, aunque también algo más marcados en el hemicuerpo izquierdo.
- Dificultades en la organización visoespacial.
- Dificultades para trabajar con información nueva y adaptarse a situaciones novedosas complejas.
- Déficits en la resolución de tareas no verbales, formación de conceptos y creación de hipótesis.
- Dificultades en la percepción del sentido del tiempo.
- Buen desarrollo de las habilidades verbales automatizadas.
- Verborrea caracterizada por ser mecánica, repetitiva, dentro de los trastornos de la pragmática del lenguaje.
- Déficits en la mecánica aritmética.
- Déficits importantes en la percepción, juicio y en la interacción social.

En cierto modo, se podría decir que estos niños presentan una capacidad verbal muchas veces superior a lo que se espera para su propia edad, como signo de que ese hemisferio izquierdo actúa compensando un poco esas dificultades a nivel derecho (Del Olmo, 2022). Justo al revés de lo que ocurre en niños con alteraciones del lenguaje que compensan de manera visual su comprensión del entorno.

2.4. Afasias

2.4.1. Afasia congénita

La afasia congénita es un trastorno del lenguaje que influye tanto en la comprensión como en la expresión. Se debe a una lesión en el Sistema Nervioso Central (SNC) antes del desarrollo del lenguaje que impide su posterior desarrollo, es decir, se identificaría como un grave retraso al no haber adquirido aún la expresión y la comprensión del lenguaje a los cinco años. Lo anterior ocasiona que sea la forma más grave los trastornos evolutivos del lenguaje. Si se desconoce la etiología puede ser un trastorno que se confunda con el TDL o con la afasia infantil adquirida.

2.4.2. Afasia infantil adquirida

Este trastorno constituye la pérdida total o parcial del lenguaje debido a una lesión cerebral sobrevenida que afecta a las áreas relacionadas directamente con el lenguaje. Este problema afecta a niños cuyo desarrollo lingüístico básico si había comenzado, pero aún no había llegado a término, es decir, es posterior a la afasia congénita, pero anterior a la afasia adquirida adulta.

Los síntomas se asemejan a los de afasia adquirida, pero son menos específicos y su gravedad depende del alcance de la lesión y las zonas afectadas, así como el momento en el que se produce esta.

2.4.3. Afasia adquirida

La afasia adquirida es un trastorno del lenguaje que constituye la pérdida total o parcial de este a consecuencia de un daño cerebral y que, por lo general, compromete todas sus modalidades: expresión y comprensión del lenguaje oral, escritura y comprensión de lectura (Barrezueta et al., 2022).

Cada una de estas puede afectar cualitativa y cuantitativamente de forma diferente, conformando grupos sindromáticos que pueden coexistir con deficiencias en el procesamiento cognitivo. El síntoma más preponderante en este trastorno es la *anomia*, dificultad para evocar las palabras. Generalmente, las afasias adquiridas se pueden clasificar en dos grandes grupos: fluentes y no fluentes.

2.4.3.1. Afasias fluentes

Las afasias fluentes se caracterizan por un discurso productivo, en cuanto a la cantidad de palabras, que en ocasiones puede estar aumentado y llegar a la logorrea. Es frecuente que el discurso sea poco informativo, presentando más palabras funcionales que de contenido (Maldavsky et al., 2008).

Frecuentemente la articulación es sin esfuerzo y adecuada, así como la longitud del enunciado y la línea melódica. En cuanto a la gramática, se encuentra generalmente conservada, ya que pueden presentar Paragramatismo (González et al., 2007).

Los errores más comunes son: las parafasias fonémicas, semánticas, verbales y neológicas. Estas afecciones se producen por lesiones localizadas detrás de la cisura de Rolando (región témporo-parietal).

2.4.3.2. Afasias no fluentes

Las afasias no fluentes, en la mayoría de los casos, presentan reducción del discurso tanto cualitativa como cuantitativamente. Se caracterizan principalmente por la dificultad para iniciar enunciados (González y Hornauer-Hughes, 2014).

La articulación es laboriosa y en los cuadros más graves, se puede observar producción de sílabas aisladas y estereotipias, llegando en algunos casos al mutismo. La longitud de los enunciados es breve y la prosodia se encuentra alterada. Las deformaciones fonológicas y errores semánticos son infrecuentes. La morfosintaxis está alterada, observándose más palabras de contenido que funcionales (Berthier et al., 2011).

Además, poseen dificultad para acceder a los verbos con carga semántica. Ésta puede coexistir con disartria y apraxia del habla. Las lesiones que producen estos tipos de afasias se localizan por delante de la cisura de Rolando.

2.4.4 Afasia adquirida con epilepsia: Síndrome de Landau Kleffner

La afasia adquirida con epilepsia (síndrome de Landau – Kleffner) se trata de un trastorno en el que el niño, habiendo progresado de un modo normal en la adquisición del lenguaje, pierde la

capacidad de comprensión y de expresión del mismo, pero conserva la inteligencia general (Pearl et al., 2001).

La aparición del trastorno se acompaña de anomalía paroxísticas en el electroencefalograma (casi siempre en los lóbulos temporales, normalmente de un modo bilateral, pero con frecuencia con un trastorno disrítmico más generalizado) y, en la mayoría de los casos, también de ataques epilépticos. Dicha aparición suele tener lugar entre los tres y los siete años, pero puede tener lugar antes o después, durante la infancia (Caraballo et al., 2014).

En la cuarta parte de los casos, la pérdida del lenguaje tiene lugar de una manera gradual durante un período de varios meses, pero lo más frecuente es que la pérdida sea brusca, en el curso de día o semanas. En este sentido, es muy característico que el deterioro de la comprensión del lenguaje sea profundo, y que las dificultades para la comprensión de los sonidos sean la primera manifestación del trastorno (Robinson et al., 2001).

Así pues, algunos niños enmudecen totalmente, otros limitan su expresión a una jerga particular, mientras que otros presentan déficits más o menos leves en la expresión y la fluidez verbal, a menudo, acompañado por dislalias. En los meses posteriores a la pérdida inicial del lenguaje son bastantes frecuentes los trastornos del comportamiento y los emocionales, pero, estos, tienden a mejorar a medida que el niño adquiere algún medio de comunicación (Stefanatos, 2011).

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

Sección 3.1 Criterios diagnósticos DSM-5

El DSM-5 (APA, 2013, p.39) establece una clasificación general para las dificultades relacionadas con el aprendizaje. Los criterios se exponen a continuación:

A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades:

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo (p. ej., lee palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras).

2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee (p. ej., puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee).

3. Dificultades ortográficas (p. ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes).

4. Dificultades con la expresión escrita (p. ej., hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración; organiza mal el párrafo; la expresión escrita de ideas no es clara).

5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo (p. ej., comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones; cuenta con los dedos para suma números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales; se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos).

6. Dificultades con el razonamiento matemático (p. ej., tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos).

B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) estandarizadas administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada.

C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo (p. ej., en exámenes programados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas).

D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas.

Además, el DSM-5 (APA, 2013) establece varios aspectos específicos: han de cumplirse, al menos, cuatro de los criterios anteriores atendiendo al análisis individual de cada caso; se debe especificar si la dificultad se encuentra en el área de la lectura, escritura o matemáticas; y, por último, se señalará la gravedad actual como leve, moderado o grave.

A continuación, se desarrollan más detenidamente las dificultades expuestas en el párrafo anterior.

Sección 3.2 Dislexia

Las dificultades en el aprendizaje de la lectura están caracterizadas por un trastorno neurológico para la adquisición de una decodificación fluida de palabras. La sintomatología de la dislexia refleja una conducta con una variación genética (Plomin y Kovas, 2005) y una distribución normal, y por tanto, debería entenderse como un trastorno dimensional, más que como un trastorno discreto (Fletcher, 2009).

3.2.1. Acote terminológico y taxonomía

La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluente de las palabras (escritas) y déficit en la decodificación (lectora) y en la escritura. Estas dificultades resultan de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Son inesperadas (discrepantes) en relación con otras habilidades cognitivas (que se desarrollan con normalidad) y una adecuada instrucción escolar.

Como consecuencias secundarias, pueden presentarse problemas en la comprensión lectora y una experiencia en lectura que puede afectar al incremento del vocabulario y de la base de conocimientos (Rello, 2019).

En lo que respecta a la tipología de dislexia, es importante tener en cuenta que los trastornos de lectura se pueden producir cuando una lesión cerebral daña alguna de las áreas o circuitos responsables de esos procesos. A esos trastornos de lectura producidos por lesión cerebral se los conoce con el nombre de dislexias adquiridas, (referidas a las alteraciones en la capacidad lectora de personas que previamente leían normalmente pero que pierden esta habilidad como resultado de un daño cerebral [lesión o neuropatología degenerativa]) para diferenciados de las dislexias evolutivas, de origen neurológico, que aparecen durante el desarrollo infantil, en ausencia de lesión cerebral, y son las más comunes en el ámbito educativo (Cuetos, 2018).

En lo que respecta a las primeras, en términos generales, se distinguen dos tipos: las periféricas, originadas por lesión en alguno de los componentes más periféricos del sistema y las centrales, originadas en el procesamiento léxico-semántico (Cuetos, 2018).

Dentro de las periféricas, las más estudiadas son la dislexia atencional, la dislexia por negligencia (ambas por lesión en el sistema atencional) y la dislexia visual por alteraciones de tipo perceptivo. También se suele incluir, entre las dislexias periféricas, la alexia pura o dislexia letra a letra, aunque realmente las alteraciones en esta dislexia, como se verá más adelante, se encuentran a nivel de palabra. Finalmente, dentro de las dislexias centrales, las tres más conocidas son la dislexia fonológica, la superficial y la profunda (Tabla 2).

Tabla 2.

Tipología de dislexia central (Cuetos, 2018)

Tipología de Dislexia Central	Descripción
Dislexia fonológica	Quienes la poseen leen correctamente las palabras familiares, pero tienen dificultades para leer las palabras poco familiares y, especialmente, las pseudopalabras. La mayor parte de los errores que cometen son errores visuales en las palabras y lexicalizaciones en las pseudopalabras, es decir, convertidas en palabras de parecido ortográfico. Existe una dificultad para leer las palabras desconocidas, y la variable más determinante en su ejecución es la frecuencia: pueden leer las palabras de alta frecuencia, pero fallan en las de baja frecuencia.
Dislexia Superficial	Quienes la poseen leen sin dificultad las palabras regulares, sean familiares o desconocidas, e incluso las pseudopalabras, pero tienen graves dificultades para leer las palabras irregulares que no se ajustan a las reglas grafema-fonema. La mayor parte de los errores que se cometen son regularizaciones, es decir, las pronuncian como si se ajustasen a esas reglas. Dentro de ella hay tres variedades: dislexia superficial de input, dislexia superficial central y dislexia superficial de output.
Dislexia Profunda	Es la más grave de todas las dislexias adquiridas. Los pacientes con dislexia profunda son incapaces de leer pseudopalabras y palabras desconocidas, y tienen dificultades para leer ciertas clases de palabras, como las abstractas, las palabras funcionales o los verbos. Producen errores visuales, derivativos y lexicalizaciones, pero los errores más característicos son los semánticos, esto es, sustituyen la palabra que tienen que leer por otra con la que no tiene ninguna relación ortográfica ni fonológica, pero sí de significado. De hecho, aunque son muchos los síntomas, los dos más característicos son la incapacidad para leer pseudopalabras y la comisión de errores semánticos. También hay tres variedades de dislexia profunda: de input, central y de output.

Sección 3.3 Disortografía

Según Romero et al. (2020), la disortografía, como trastorno, incluye exclusivamente errores en la escritura, sin necesidad de que tales errores se den también en la lectura. Por tanto, un sujeto que presenta esta alteración no tiene, necesariamente, que leer mal. Así, a diferencia de la dislexia, puede asegurarse que no afecta a la lectura y que tiene entidad propia. Mientras que la primera provoca errores en la lectura y en la escritura, la segunda tan solo genera trastornos en el proceso escritor, de modo que un sujeto con dislexia presentará también disortografía pero un sujeto con disortografía no necesariamente es un disléxico (Rivas y Fernández, 2011).

Para Cervéra-Mérida y Ygual-Fernández (2006), dicho trastorno de escritura está constituido por el conjunto de errores de dicha destreza que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía.

En este sentido, los errores se centran en la aptitud para transmitir el código lingüístico hablado o escrito por medio de los grafemas o letras correspondientes, respetando la asociación correcta entre los fonemas y sus grafemas, las peculiaridades ortográficas de algunas palabras, en las que la correspondencia no es tan clara, y las reglas de ortografía.

Por último, tal y como señala Mendes (1978), se relacionan con las dispedagogías, es decir, las dificultades de aprendizaje que involucran al docente, en este caso se puede hacer referencia al uso de métodos de enseñanza inapropiados (por ejemplo, el dictado) o técnicas que no se ajustan a las necesidades individuales del alumnado (no respetando, por ejemplo, su ritmo de aprendizaje).

Finalmente, siguiendo a Otondo y Bascur (2020) puede decirse que la naturaleza de la disortografía está clasificada en problemas perceptivos, métodos incorrectos de enseñanza, problemas madurativos, dificultades de lateralización, trastornos de deficiencia psicomotora y trastornos de esquema corporal y de funciones perceptivo-motrices. En lo que respecta a la clasificación, existen distintos tipos: temporal, perceptivo-Kinestésica, disortocinética, visoespacial, dinámica y semántica.

Sección 3.4 Discalculia

La discalculia se utiliza como término alternativo para referirse a una serie de dificultades caracterizado por una problemática en el "procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido" (APA, 2013, p.40). Cuando se emplea el término discalculia para hacer referencia a este perfil específico de dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, es necesario identificar y señalar, asimismo, la posible presencia de otras dificultades asociadas**,** como aquellas relacionadas con el razonamiento matemático o con la adecuada interpretación y resolución de problemas formulados verbalmente.

Las dificultades asociadas a la discalculia pueden manifestarse en diferentes componentes del procesamiento numérico y del aprendizaje matemático. Entre los errores más frecuentes se encuentran las dificultades para comprender y representar cantidades y magnitudes numéricas, comparar números o realizar un conteo estable; por ejemplo, presentar dificultades para determinar qué cantidad es mayor entre *7* y *9* o para establecer correctamente la correspondencia entre un numeral y el conjunto que representa (Butterworth et al., 2013). También pueden aparecer dificultades en la transcodificación numérica, es decir, en la conversión entre diferentes códigos de representación de los números, como escribir *24* cuando se dicta «cuarenta y dos», leer *307* como «treinta y siete» o escribir *251* ante la expresión verbal «doscientos quince» (Kaufmann et al., 2013). Asimismo, pueden observarse problemas relacionados con la comprensión del valor posicional, como interpretar incorrectamente el papel que desempeñan las cifras en números como *25* o *205*, así como dificultades en la realización de operaciones aritméticas y en la recuperación automatizada de hechos numéricos básicos. Por ejemplo, algunos niños pueden recurrir al conteo con los dedos para resolver operaciones sencillas como *6 + 3* o presentar dificultades para recuperar de manera fluida resultados de las tablas de multiplicar (Butterworth et al., 2013). También se han descrito dificultades en la estimación y representación espacial de las magnitudes numéricas, como situar de forma imprecisa un número en una recta numérica. No obstante, estos errores no aparecen necesariamente de forma conjunta ni con la misma intensidad, ya que las dificultades

matemáticas presentan una considerable heterogeneidad y pueden afectar a distintos componentes del procesamiento numérico y del razonamiento matemático.

OTROS TRASTORNOS

Adicionalmente y de forma excepcional, aunque no se encuentran clasificados dentro del DSM5, se presentan otros trastornos relacionados con la escritura. Se desarrollan, a continuación.

Sección 4.1 Disgrafía

En lo que respecta a esta alteración en la escritura, puede definirse como un trastorno de carácter perceptivo-motriz en la forma de dibujar signos gráficos que afecta a la calidad de la escritura y es generalmente de etiología funcional (Santos, 2006). Tal y como apunta Vega (2018), las alteraciones derivadas de él están relacionadas con el sistema de procesamiento implicado en la secuenciación, provienen de inadecuados patrones de estimulación que inhabilitan el manejo de la escritura y serán detectadas tomando en cuenta los patrones de trazado, forma, legibilidad, fluidez y significado.

En lo que se refiere a su clasificación, se debe tener en cuenta que existen distintos tipos de trastornos disgráficos a partir del sistema típico de escritura descrito en el tema anterior. En lo que se refiere a su clasificación, se distingue entre agrafías o disgrafías adquiridas y agrafias o disgrafías evolutivas.

Así pues, atendiendo a la taxonomía general, las disgrafías adquiridas son aquellas que seproducen en sujetos que pierden o empeoran la capacidad de escribir como consecuencia de un accidente o lesión cerebral. Debido a que son numerosas las regiones cerebrales que contribuyen a la habilidad de la escritura, los síntomas de los sujetos con este polo taxonómico pueden ser muy variados, dependiendo de la zona cerebral dañada.

Por su parte, las disgrafías evolutivas se refieren a aquellos sujetos que experimentan problemas en la escritura sin que haya una razón aparente, pues suelen presentar una inteligencia normal, una escolarización adecuada y un desarrollo perceptivo y psicomotor adecuado, tal y como señala Grande (2009).

Así, los fallos se pueden producir por mal funcionamiento de alguno de los procesos que componen el sistema de escritura y, así, en unos casos los problemas son de tipo motor, ya que los sujetos tienen dificultades para dibujar correctamente las letras, y, en otros casos, son lingüísticos, puesto que no consiguen aprenderse las reglas de conversión fonema a grafema y cometen muchas faltas de ortografía o de planificación porque son incapaces de redactar un pequeño texto (Santana del Sol et al. 2021).

En definitiva, hay que tener en cuenta que, cuando se trata de sujetos que están aprendiendo a escribir, las alteraciones gozan de tanta pureza como en las disgrafías producidas por lesión cerebral, puesto que al tratarse de un sistema que se está formando, el hecho de que un proceso no funcione adecuadamente suele conllevar alteraciones en el desarrollo de los demás (Cuetos, 2018).

Sección 4.2 Hipergrafía

Se trata de una necesidad impulsiva de escribir ocasionada por una liberación de esta conducta, es decir, una escritura excesiva, minuciosa y reiterativa. Es frecuente en cuadros con alteraciones importantes de la comprensión, como las afasias de Wernicke. Se encuentra, normalmente, asociada a una estereotipia. En la ilustración 1 puede verse como un sujeto, al proporcionarle lápiz y papel, comienza compulsivamente a escribir la palabra casa. Además, cuando se le demanda que escriba una frase dictada, solo escribe varias veces la palabra (Guimaraes, 2022).

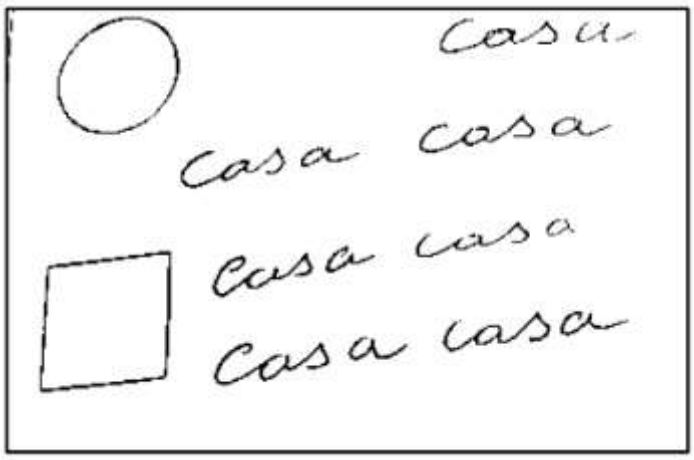


Ilustración 1.

Muestra de una estereotipia escrita asociada a hipergrafía (Guimaraes, 2022)

RESUMEN DEL TEMA

El lenguaje oral cumple funciones comunicativas, sociales, cognitivas y de autorregulación. Las alteraciones del lenguaje pueden afectar a la interacción, el desarrollo emocional y el rendimiento académico. Los trastornos pueden comprometer diferentes componentes: fonología, morfosintaxis, léxico-semántica, pragmática y discurso.

1. Trastornos del lenguaje oral

Inicio tardío del lenguaje (ITL). Se caracteriza principalmente por un vocabulario reducido (<50 palabras inteligibles) o ausencia de combinaciones de dos palabras a los 24 meses. Puede afectar a la expresión, a la comprensión o a ambas. No constituye por sí mismo un diagnóstico de TDL: algunos niños presentan recuperación espontánea, mientras que otros desarrollan dificultades persistentes. Por ello, es fundamental el seguimiento evolutivo y la intervención temprana cuando existen dificultades significativas, especialmente en comprensión y expresión.

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL). Es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades significativas y persistentes en el lenguaje oral que afectan a la comunicación, la participación social y/o el aprendizaje. Puede comprometer una o varias dimensiones lingüísticas: fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática y discurso. El consenso de 2026 establece que el TDL se utiliza cuando no existe una condición biomédica identificable que explique las dificultades lingüísticas. Su identificación se sitúa preferentemente a partir de los 4 años, considerando la persistencia, gravedad e impacto funcional. El diagnóstico debe ser multidimensional y clínico-funcional, integrando pruebas estandarizadas, observación, muestras de lenguaje, información familiar y educativa, audición y funcionamiento cognitivo. El logopeda/fonoaudiólogo desempeña un papel central dentro de un abordaje interdisciplinar.

Trastorno del Lenguaje (TL). Es un concepto más amplio que hace referencia a una alteración persistente y significativa del lenguaje que afecta al funcionamiento comunicativo. Puede existir una condición biomédica asociada que explique las dificultades. No existe un perfil único ni se recomiendan subtipos rígidos; deben describirse individualmente los dominios lingüísticos afectados. El TDL se considera dentro del TL, diferenciándose fundamentalmente por la ausencia de una condición biomédica identificable que explique las dificultades.

Trastorno de Aprendizaje No Verbal (TANV). Se caracteriza por dificultades en razonamiento espacial, habilidades visoconstructivas, coordinación motora fina, percepción táctil y organización visoespacial, junto con posibles dificultades socioemocionales. Es característica la discrepancia entre habilidades verbales y visoperceptivas. Pueden aparecer problemas de adaptación a situaciones novedosas, resolución de tareas no verbales, formación de conceptos, percepción temporal e interacción social, mientras que las habilidades verbales automatizadas pueden estar relativamente preservadas.

2. Afasias

La afasia supone una pérdida o alteración del lenguaje asociada a una lesión cerebral.

- Afasia congénita: lesión del SNC previa al desarrollo del lenguaje que impide su adquisición; afecta comprensión y expresión.
- Afasia infantil adquirida: pérdida parcial o total del lenguaje tras una lesión cerebral cuando el desarrollo lingüístico aún no había finalizado.

- Afasia adquirida: pérdida parcial o total del lenguaje después de un daño cerebral; puede afectar expresión, comprensión, lectura y escritura. La anomia (dificultad para evocar palabras) es un síntoma frecuente.

Las afasias fluentes presentan discurso abundante, a veces con logorrea, generalmente con articulación y gramática relativamente conservadas, pero con errores como parafasias fonémicas, semánticas, verbales y neologismos. Las afasias no fluentes presentan reducción del discurso, dificultad para iniciarlo, articulación laboriosa, enunciados breves, alteración de la prosodia y morfosintaxis, pudiendo coexistir con disartria o apraxia del habla.

El síndrome de Landau-Kleffner es una afasia adquirida asociada a epilepsia: tras un desarrollo lingüístico inicialmente normal, el niño pierde comprensión y expresión, conservando la inteligencia general. Se relaciona con anomalías del EEG y crisis epilépticas, y suele aparecer durante la infancia.

3. Trastornos del aprendizaje

El DSM-V desarrolla los criterios de diagnóstico para los trastornos del aprendizaje que, además se pueden clasificar en función del área de dificultad: lectura, escritura o matemática.

Dislexia. Es una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico, caracterizada por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de palabras, decodificación y escritura, asociadas especialmente a un déficit fonológico. Puede producir secundariamente dificultades de comprensión lectora y limitar el desarrollo de vocabulario y conocimientos. Se diferencian dislexias evolutivas (aparecen durante el desarrollo) y adquiridas (tras una lesión cerebral). Entre las adquiridas centrales destacan la fonológica (dificultad con palabras poco familiares y pseudopalabras), superficial (dificultad con palabras irregulares) y profunda (incapacidad para pseudopalabras y presencia característica de errores semánticos).

Disortografía. Afecta específicamente a la escritura ortográfica, sin implicar necesariamente dificultades lectoras. Los errores afectan a la correspondencia fonema-grafema, las peculiaridades ortográficas y las reglas de ortografía. Por tanto, una persona con dislexia puede presentar disortografía, pero la disortografía puede aparecer sin dislexia.

Discalculia. Puede entenderse como una dificultad en el procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido.

4. Otros trastornos

Disgrafía. Trastorno perceptivo-motriz que afecta a la calidad del trazado escrito. Puede ser adquirida, tras lesión cerebral, o evolutiva, cuando aparecen dificultades sin una causa aparente pese a una inteligencia y escolarización adecuadas. Puede afectar a procesos motores, lingüísticos o de planificación de la escritura.

Hipergrafía. Consiste en una escritura excesiva, impulsiva, minuciosa o reiterativa, frecuentemente asociada a alteraciones importantes de la comprensión y a estereotipias escritas, como puede observarse en algunas afasias.

Clave para diferenciar: ITL = inicio tardío que requiere seguimiento; TDL = dificultades lingüísticas persistentes sin condición biomédica explicativa; TL = categoría más amplia de alteración persistente del lenguaje; TANV = dificultades principalmente no verbales con perfil verbal relativamente preservado; afasia = pérdida del lenguaje por daño cerebral; dislexia =

lectura/decodificación; disgrafía = trazado y componente perceptivo-motor de la escritura; disortografía = ortografía; hipergrafía = escritura excesiva y reiterativa.

GLOSARIO

Afasia: Alteración o pérdida parcial o total del lenguaje como consecuencia de una lesión o daño cerebral. Puede afectar a la expresión, comprensión, lectura y escritura.

Afasia adquirida: Pérdida parcial o total del lenguaje producida por un daño cerebral. Puede comprometer diferentes modalidades lingüísticas y presentar perfiles fluentes o no fluentes.

Afasia congénita: Trastorno del lenguaje producido por una lesión del sistema nervioso central antes del desarrollo del lenguaje, que dificulta gravemente la adquisición de la comprensión y expresión lingüística.

Afasia infantil adquirida: Pérdida total o parcial del lenguaje provocada por una lesión cerebral cuando el desarrollo lingüístico del niño ya se había iniciado, pero todavía no había finalizado.

Afasia fluente: Tipo de afasia caracterizado por un discurso abundante, en ocasiones con logorrea, generalmente con articulación y longitud de los enunciados conservadas, pero con posibles errores lingüísticos y un discurso poco informativo.

Afasia no fluente: Tipo de afasia caracterizado por reducción del discurso, dificultad para iniciar enunciados, articulación laboriosa, enunciados breves y alteraciones morfosintácticas y prosódicas.

Anomia: Dificultad para evocar o recuperar las palabras que se desean expresar. Constituye uno de los síntomas más frecuentes de las afasias adquiridas.

Aprendizaje no verbal: Conjunto de habilidades relacionadas con el procesamiento espacial, visoperceptivo, visoconstructivo, motor y socioemocional, que pueden encontrarse alteradas en el TANV.

Discalculia: Trastorno del aprendizaje relacionado con las dificultades en el ámbito matemático. El documento la incluye dentro de los trastornos del aprendizaje, aunque no desarrolla su definición en esta unidad.

Disgrafía: Trastorno perceptivo-motriz que afecta a la calidad de la escritura y a la ejecución de los signos gráficos. Puede comprometer el trazado, la forma, la legibilidad y la fluidez.

Disgrafía adquirida: Alteración de la capacidad de escribir producida por una lesión o accidente cerebral en una persona que previamente había adquirido la escritura.

Disgrafía evolutiva: Dificultades en la escritura que aparecen durante su adquisición sin una causa aparente, pese a una inteligencia, escolarización y desarrollo perceptivo-motor adecuados.

Dislexia: Dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico caracterizada por problemas en el reconocimiento preciso y fluido de palabras, la decodificación lectora y la escritura, asociada especialmente a dificultades en el componente fonológico del lenguaje.

Dislexia adquirida: Alteración de la lectura que aparece después de que una persona haya adquirido normalmente esta habilidad y posteriormente la pierda como consecuencia de una lesión cerebral o neuropatología.

Dislexia evolutiva: Dificultad lectora de origen neurológico que aparece durante el desarrollo infantil, sin que exista una lesión cerebral adquirida.

Dislexia fonológica: Tipo de dislexia adquirida en la que se leen relativamente bien las palabras familiares, pero existen dificultades importantes para leer palabras poco familiares y, especialmente, pseudopalabras.

Dislexia profunda: Forma grave de dislexia adquirida caracterizada, entre otros aspectos, por la incapacidad para leer pseudopalabras y la aparición de **errores semánticos**, sustituyendo una palabra por otra relacionada por su significado.

Dislexia superficial: Tipo de dislexia adquirida en la que existe dificultad para leer palabras irregulares, mientras que las palabras regulares y pseudopalabras pueden ser leídas mediante las reglas grafema-fonema. Son frecuentes las regularizaciones.

Disortografía: Trastorno específico de la escritura caracterizado por errores ortográficos que afectan a la correspondencia entre fonemas y grafemas, las peculiaridades ortográficas de determinadas palabras y las reglas de ortografía, sin implicar necesariamente dificultades en la lectura.

Error semántico: Error característico de la dislexia profunda en el que se sustituye la palabra que debe leerse por otra que no presenta relación ortográfica o fonológica, pero sí relación de significado.

Hipergrafía: Necesidad impulsiva de escribir que se manifiesta mediante una producción escrita excesiva, minuciosa y reiterativa. Puede aparecer asociada a alteraciones importantes de la comprensión y a estereotipias escritas.

Inicio tardío del lenguaje (ITL): Situación evolutiva caracterizada por una aparición tardía del lenguaje, con indicadores como un vocabulario inferior a 50 palabras inteligibles o ausencia de emisiones de dos palabras a los 24 meses. No equivale automáticamente a TDL.

Logorrea: Producción verbal excesiva y abundante que puede aparecer en las afasias fluentes.

Parafasia: Producción de una palabra o sonido diferente del esperado durante el habla. En las afasias fluentes pueden aparecer parafasias fonémicas, semánticas, verbales y neológicas.

Pseudopalabra: Secuencia de sonidos o letras que respeta determinadas características de una palabra, pero que no constituye una palabra real. Su lectura resulta especialmente relevante para identificar dificultades en la dislexia fonológica y profunda.

Trastorno de Aprendizaje No Verbal (TANV): Categoría clínica neuropsicológica caracterizada por dificultades en razonamiento espacial, habilidades visoconstructivas, control motor fino y táctil, junto con posibles dificultades socioemocionales y una discrepancia entre capacidades verbales y visoperceptivas.

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL): Trastorno del neurodesarrollo que implica dificultades significativas y persistentes en el desarrollo del lenguaje oral, sin que exista una condición biomédica identificable que explique las dificultades lingüísticas. Puede afectar a diferentes dimensiones del lenguaje y repercutir en la comunicación, participación social y aprendizaje.

Trastorno del Lenguaje (TL): Alteración persistente y significativa del lenguaje que afecta al funcionamiento comunicativo. Constituye un concepto más amplio que puede incluir dificultades asociadas a una condición biomédica identificable.

Trastorno del neurodesarrollo: Alteración que se manifiesta durante el desarrollo y que puede afectar diferentes funciones, entre ellas el lenguaje. En el documento, el TDL se define específicamente como un trastorno del neurodesarrollo.

Estereotipia escrita: Producción repetitiva y persistente de una misma palabra o secuencia escrita, que puede aparecer asociada a la hipergrafía.

Fluidez verbal: Capacidad para producir lenguaje oral de manera continua y con facilidad. En las afasias fluentes suele estar relativamente conservada o incluso aumentada, mientras que en las no fluentes se encuentra reducida.

Morfosintaxis: Componente del lenguaje relacionado con la estructura y organización de las palabras y las oraciones. Puede encontrarse alterado en los trastornos del lenguaje y especialmente en las afasias no fluentes.

Pragmática: Dimensión del lenguaje relacionada con su utilización comunicativa y social. Las dificultades pragmáticas pueden formar parte de los perfiles de trastorno del lenguaje.

Semántica: Dimensión del lenguaje relacionada con el significado de las palabras y los mensajes. Puede estar afectada en distintos trastornos del lenguaje y participa en determinados errores de las afasias y dislexias.

Síndrome de Landau-Kleffner: Trastorno caracterizado por la pérdida adquirida de la comprensión y expresión del lenguaje en niños que habían desarrollado inicialmente el lenguaje de forma normal. Se asocia a anomalías epileptiformes en el EEG y, frecuentemente, a crisis epilépticas.

TDL y TL – diferencia fundamental: El **TL** constituye el concepto más amplio de alteración persistente y significativa del lenguaje. El **TDL** se utiliza cuando las dificultades lingüísticas persisten y no existe una condición biomédica identificable que las explique.

BIBLIOGRAFÍA

Ahufinger, N., Ferinu, L., Pacheco-Vera, F., Sanz-Torrent, M., y Andreu, L. (2021). El trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) más allá de las dificultades lingüísticas: Memoria y atención. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 41*(1), 4-16

Andreu Barrachina, L., Auza, A., Coloma, C. J., Dioses Chocano, A. S., Lara Díaz, M. F., Maggio, V., Simón-Cereijido, G., & Consorcio AHITL. (2026). Estudio de consenso Delphi sobre el trastorno del lenguaje oral en los países hispanohablantes. *Revista de Investigación en Logopedia*, *16*(2), e106526. https://doi.org/10.5209/rlog.106526

Barragán, P. E., y Lozano, S. S. (2011). Identificación temprana de trastornos del lenguaje. *Revista Médica Clínica Las Condes*, *22*(2), 227-232.

Barrezueta, W. M. T., Mero, L. M. P., y Acebo, M. E. C. (2022). Intervención logopeda mediante la Entonación Melódica en las afasias no fluentes. *Salud y Ciencias Medicas*, *2*(1), 37-52.

Berthier, M. L., García Casaresa, N., y Dávila, G. (2011). Afasias y trastornos del habla. *Medicine*, *10*(74), 5035-5041.

Billard, C. (2014). Desarrollo y trastornos del lenguaje oral en la infancia. *EMC-Pediatría*, *49*(4), 1-11.

Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., Catalise-2 Consortium, Adams, C., y House, A. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58*(10), 1068-1080

Bishop, D. y Leonard, L. (2001). *Speech and language impairment in children: Causes, characteristics, intervention, and outcome*. Oxford: Psychology Press.

Butterworth, B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: From brain to education. *Science, 332*(6033), 1049–1053. https://doi.org/10.1126/science.1201536

Caraballo, R. H., Cejas, N., Chamorro, N., Kaltenmeier, M. C., Fortini, S., y Soprano, A. M. (2014). Landau–Kleffner syndrome: A study of 29 patients. *Seizure*, *23*(2), 98-104.

Cervéra-Mérida, J. F., y Ygual-Fernández, A. (2006). Uma propuesta de intervención em trastornos disortográficos atendiendo a la semiologia de los errores. *Rev Neurol*, *42*(2), 117-26.

Crespo-Allende, N., y Alfaro-Faccio, P. (2010). Desarrollo tardío del lenguaje: la conciencia metapragmática en la edad escolar. *Universitas psychologica*, *9*(1), 229-240.

Cruz-Hernández, L., y Salvador-Cruz, J. (2020). Trastorno de Aprendizaje no verbal: Revisión y análisis bajo un abordaje neuropsicológico. *Edupsykhé. Revista de Psicología y Educación*, *17*(1), 1-17.

Cuetos, F. (2018). *Neurociencia del lenguaje: bases neurológicas e implicaciones clínicas.* Editorial Médica Panamericana

Fletcher, J.M. (2009). Dyslexia: The evolution of a scientific concept. *Journal of the International Neuropsychological Society, 15* (4), 501-508.

Gallardo, J. R., y Gallego, J. L. (2003). *Manual de Logopedia Escolar. Un enfoque práctico*. Ediciones Aljibe Málaga.

Guimarães, C. S. (2022). A hipergrafia na síndrome de Geschwind-Waxman: uma revisão da literatura. *Medicina balear*, *17*(3), 101-120.

González, R., y Hornauer-Hughes, A. (2014). Afasia: una perspectiva clínica. *Revista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile*, *25*, 291-308.

González, R., Vásquez, C., Venegas, P., Behrens, M. I., Donoso, A., y Massardo, T. (2007). Afasia progresiva fluente:¿ Una forma de presentación inicial de demencia semántica?. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, *45*(1), 43-50.

Grande, G. (2009). *La cuestión de la dislexia y la disgrafía en la adquisición de segundas lenguas: estudios de caso en ELE*. Biblioteca virtual redELE.

Hincapié, L., Giraldo-Prieto, M., Lopera-Restrepo, F., Pineda-Salazar, D. A., Castro-Rebolledo, R., Lopera-Vásquez, J. P. (2008). Trastorno Específico del Desarrollo del Lenguaje en una población infantil colombiana. *Universitas Psychologica, 7*(2), 557-569

Kaufmann, L., Mazzocco, M. M., Dowker, A., von Aster, M., Göbel, S. M., Grabner, R. H., Henik, A., Jordan, N. C., Karmiloff-Smith, A. D., Kucian, K., Rubinsten, O., Szucs, D., Shalev, R., & Nuerk, H.-C. (2013). Dyscalculia from a developmental and differential perspective. *Frontiers in Psychology*, *4*, 516. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00516

Magdalena, D.T. (2020). *Trastorno del desarrollo del lenguaje y bilingüismo*. Trabajo de Fin de Grado, Universidad de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Recuperado de: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/19742/Trastorno%20del%20Desarrollo%20del%20Lenguaje%20y%20Biling%C3%BCismo.pdf?sequence=1

Maldavsky, D., Cantis, J., De Durán, R., y Grigera, H. G. (2008). Un caso de afasia con fluencia motriz y paraverbal. *Summa Psicológica UST*, *5*(1), 101-125.

Martínez, I. E. G. (2017). Inicio tardío del lenguaje: revisión general. *Revista Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría*, *5*(3), 89-96.

Mendes, C. B. (1978). Dislexia ou dispedagogia. *Análise Psicológica*, *1*(2), 157-162.

Moreno-Flagge, N. (2013). Trastornos del lenguaje. Diagnóstico y tratamiento. *Rev Neurol*, *57*(Supl 1), S85-94.

Otondo, M., y Bascur, C. (2020). Disortografía y métodos de intervención educativa. *Praxis Pedagógica*, *20*(27), 5-28.

Pearl, P. L., Carrazana, E. J., y Holmes, G. L. (2001). The landau-kleffner syndrome. *Epilepsy currents*, *1*(2), 39-45.

Peñafiel, M. (2012). Indicadores tempranos de los trastornos del lenguaje. *Centro Superior Estudios Universitarios La Salle. Universidad Autónoma. Madrid: Exlibris Ediciones*, 154.

Plomin, R., y Kovas, Y. (2005). Generalist genes and learning disabilities. *Psychological bulletin*, 131(4), 592.

Rello, L. (2019). *Superar la dislexia*. Barcelona: PAIDÓS Educación.

Ríos-Flórez, J. A., y López-Gutiérrez, C. R. (2017). Neurobiología de los trastornos del aprendizaje y sus implicaciones en el desarrollo infantil: propuesta de una nueva perspectiva conceptual. *Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado, 11*(19), 174-192.

Rivas, R. M. y Fernández, M. P. (2011). *Dislexia, disortografía y disgrafía*. Madrid: Pirámide.

Robinson, R. O., Baird, G., Robinson, G., y Simonoff, E. (2001). Landau–Kleffner syndrome: course and correlates with outcome. *Developmental medicine and child neurology*, *43*(4), 243-247.

Romero, M. G., Alonso, J. M. R., y Romero, J. G. (2020). Aproximación conceptual a la disortografía. Aportaciones docentes. *Brazilian Journal of Development*, *6*(4), 18814-18820.

Roselli, M, Matute, E., y Ardila, A. (2010). *Neuropsicología del desarrollo infantil*. México: Ed. Manual Moderno.

Sala, M. (2020). Trastornos del desarrollo del lenguaje oral y escrito. In *Congreso de Actualización Pediatría* (Vol. 1, pp. 251-264).

Santana del Sol, Y., LLópiz Guerra, K., Sugasty Medina, M. O., Gonzales-Sánchez, A., y Valqui Oxolon, J. M. (2021). Estudios sobre la corrección de la disgrafía caligráfica en escolares con discapacidad intelectual. *Propósitos y Representaciones, 9*(1), 1-13.

Santos, M.C. (2006). Prevención de las disgrafías escolares: necesidad de la escuela actual para la atención a la diversidad: una mirada desde Cuba. *Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 15*(29), 117-133.

Stefanatos, G. (2011). Changing perspectives on Landau-Kleffner syndrome. *The Clinical Neuropsychologist*, *25*(6), 963-988.

Vega, R. (2018). *Estrategias para abordar el trastorno de la disgrafía en la enseñanza del idioma extranjero inglé*s. Machala: Universidad Técnica de Machala.